



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Saúde

Resolução SES nº 10.382, de 11 de agosto de 2025.

Dispõe sobre as regras de aplicação do Decreto Estadual nº 49.080 de 01 de agosto de 2025.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE e Gestor do Sistema Único de Saúde de Minas Gerais, no uso das suas atribuições, que lhe confere o § 1º do art. 93 da Constituição Estadual, e considerando a necessidade de regulamentar o Decreto nº 49.080 de 01 de agosto de 2025

RESOLVE:

CAPÍTULO I - Das Disposição Gerais

Art. 1º – Regulamentar, nos termos desta Resolução, as regras de aplicação do Decreto Estadual nº 49.080/2025, que dispõe sobre as normas de transferência, monitoramento, prestação de contas e avaliação dos recursos financeiros repassados pelo Fundo Estadual de Saúde - FES.

Art. 2º – Os recursos repassados nos moldes do Decreto nº 49.080/2025, são destinados às seguintes ações, em conformidade com o disposto nos incisos II, III e IV, do art. 2º daquele normativo:

I – Estratégia de saúde (ES): política pública elaborada pela Secretaria de Estado de Saúde (SES/MG) que visa financiar, com recursos transferidos pelo FES, ações e serviços públicos de saúde continuados;

II – Projeto de saúde (PS): projeto elaborado pela SES/MG, ou através de indicações de emendas parlamentares, que visa financiar, com recursos transferidos pelo FES, ações ou serviços públicos de saúde para o cumprimento de um objeto específico, que possua esforço temporário e progressivo definido em Resolução;

§1º As ações, diretrizes e regras de financiamento das estratégias e projetos de saúde serão regulamentadas através de Resolução de Financiamento e Diretrizes de Saúde da SES/MG, que deverá conter, minimamente, os artigos dispostos no modelo aprovado pela Assessoria Jurídica e disponibilizado às áreas técnicas.

§2º Para efetivação dos repasses, deverá ser formalizado Termo de Adesão, instrumento administrativo unilateral, por meio do qual os beneficiários elencados no Art. 3º do Decreto nº 49.080/2025, exceto do disposto em seu inciso IV, aderem à estratégia



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Saúde

de saúde ou ao projeto de saúde, cuja duração esteja em conformidade com a Resolução de Financiamento e Diretrizes de Saúde expedida pela SES que originou o Termo de Adesão, conforme modelo proposto no Anexo Único desta Resolução.

§3º São considerados projetos de saúde, conforme definição do inciso II deste artigo:

I - aquisição de equipamentos;

II – aquisição de veículos;

III - obras;

IV - qualificação de estrutura física de unidade de saúde;

V - implantação de serviços; ou

VI - a concessão de incentivo temporário para a mudança de algum cenário ou situação de saúde, com recursos transferidos pelo FES.

§4º O financiamento destinado às instituições privadas, sob gestão estadual, com ou sem fins lucrativos, para a execução de políticas de que tratam o inciso I deste artigo serão repassados por meio de contrato assistencial.

Art. 3º – Para fins desta Resolução, considerar-se-á:

I - área técnica: área da estrutura orgânica da SES responsável pela elaboração, monitoramento, execução orçamentária e financeira da política pública de saúde concernente ao objeto da Resolução de Financiamento e Diretrizes de Saúde e avaliação de seus resultados;

II - área gestora: área da estrutura orgânica da SES responsável pelo apoio estratégico complementar à implementação e ao monitoramento das políticas públicas de saúde e dos contratos assistenciais, em articulação com as Unidades Regionais de Saúde;

III - Unidade Regional de Saúde: responsável pelo apoio à adesão pelos municípios às estratégias e projetos de saúde, pelo apoio no monitoramento e apoio técnico ao município e pela execução complementar e descentralizada das ações relacionadas à implementação das políticas públicas de saúde e dos contratos assistenciais no âmbito dos territórios;

IV - beneficiário: entes estabelecidos no art. 3º do Decreto Estadual nº 49.080, de 01 de agosto de 2025, contemplado pelas resoluções de financiamento e Termo de Adesão da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES/MG);

V - monitoramento: atividade que visa ao acompanhamento sistemático e análise periódica da execução orçamentária, do desempenho dos indicadores e outras condicionantes aplicadas a uma Resolução de Financiamento e Diretrizes de Saúde,



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Saúde

de modo a medir e registrar o desempenho dos beneficiários e produzir informações estratégicas para a gestão de uma estratégia ou projeto de Saúde;

VI - indicador: medida, geralmente numérica, que representa e facilita a compreensão e o monitoramento de conceitos ou objetivos abstratos.

VII - ciência de resultados: procedimento pelo qual o beneficiário é formalmente informado dos resultados apurados dos indicadores vinculados a determinada Resolução de Financiamento e Diretrizes de Saúde, sendo-lhe assegurado o direito de manifestação, por meio de interposição de recurso, em caso de discordância.

VIII - Comissão Macrorregional de Acompanhamento: comissão de caráter permanente, deliberativo e de abrangência macrorregional, conforme Plano Diretor de Regionalização, com competência para deliberar sobre os recursos dos resultados do desempenho dos indicadores e metas apresentados pelos beneficiários, objeto das Resoluções de financiamento reguladas por esta norma.

§1º As áreas gestora e técnica, definidas nos incisos I e II deste artigo, a depender do caso, poderão se coincidir, e não se confundirão com as unidades da área meio.

§2º A área meio, citada no §1º deste artigo, constituem-se do conjunto de unidades e funções administrativas que não atuam diretamente na formulação ou execução das políticas públicas setoriais, mas exercem papel essencial de suporte técnico-operacional e normativo, prestando serviços transversais e estruturantes que asseguram a legalidade, a eficiência e a continuidade da gestão pública.

§3º - Os indicadores, dispostos no inciso VI deste artigo, são classificados por fonte, sendo declaratório ou oficial, e por função, ou seja, de resultado ou pagamento, nos seguintes termos:

- a) indicadores declaratórios: são aqueles cujo resultado é informado pelo próprio beneficiário, não havendo repositórios públicos de dados;
- b) indicadores oficiais: são aqueles cujo resultado é extraído de sistema de informação ou base de dados disponível publicamente;
- c) indicadores de resultado: são aqueles que procuram mensurar os objetivos gerais da política e seu custo-efetividade, não tendo impacto no pagamento dos beneficiários; e
- d) indicadores de pagamento: são aqueles que buscam mensurar o cumprimento das atividades e produtos da política, estando sua apuração diretamente vinculada ao repasse de recursos.

CAPÍTULO II - Da Elaboração de Políticas Públicas de Saúde



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Saúde

Art. 4º – A elaboração de uma Estratégia ou Projeto de Saúde será de responsabilidade da respectiva área técnica, observadas as suas atribuições previstas na estrutura orgânica da SES.

Art. 5º– Nos termos do §1º do Art. 4º do Decreto nº 49.080/2025, as políticas públicas de saúde serão divididas conforme os seguintes blocos de financiamento:

- I - Atenção Primária à Saúde;
- II - Atenção Especializada à Saúde;
- III - Atenção Hospitalar e Urgência e Emergência;
- IV - Vigilância em Saúde;
- V - Assistência Farmacêutica; e
- VI - Gestão Estratégica de Saúde.

Parágrafo único – A divisão das políticas públicas da SES/MG em blocos de financiamento, conforme estabelecido no caput deste artigo, deverá estar em consonância com a divisão das ações e programas estabelecidos na Lei Orçamentária Anual do ano corrente.

Art. 6º – A Resolução de Financiamento e Diretrizes de Saúde, no âmbito do Decreto nº 49.080/2025, é o documento que formalizará o financiamento de uma política pactuada de saúde por meio de Termo de Adesão, sendo sua elaboração de responsabilidade da respectiva área técnica, devendo conter, no mínimo:

- I - a identificação da respectiva política pública de saúde;
- II - a Comissão Macrorregional de Acompanhamento vinculada à estratégia ou ao projeto de saúde;
- III - o(s) objeto(s);
- IV - o(s) objetivos;
- V - os valores globais e/ou anuais, quando couber;
- VI - o bloco de financiamento, quando tratar-se de estratégias de saúde;
- VII - a dotação orçamentária;
- VIII - os beneficiários;
- IX - os indicadores;
- X - a periodicidade do monitoramento;
- XI - as regras de monitoramento constantes no Capítulo IV desta Resolução;
- XII - o cronograma de pagamento;
- XIII - o prazo para manifestação de interesse;
- XIV - a vigência;
- XV - rol taxativo ou exemplificativo, quando couber, das possibilidades de utilização do recurso; e
- XVI - as regras de prestação de contas constantes no capítulo V desta Resolução.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Saúde

§1º Resoluções de financiamento decorrentes do repasse de emendas parlamentares não necessitam conter o inciso IX, do caput deste artigo, conforme Parágrafo Único do Art. 18 do Decreto 49.080/ 2025.

§2º Resoluções de financiamento decorrentes de repasses obrigatórios oriundos de Portarias Ministeriais deverão seguir as regras estabelecidas pelo Ministério da Saúde, podendo não incluir um ou mais dos incisos estabelecidos no *caput* deste artigo.

§3º – O estabelecido no §1º deste artigo não confundir-se-á com a ausência de metas.

CAPÍTULO III – Da Implementação das Políticas Públicas de Saúde

Art. 7º – Para publicação de uma Resolução de Financiamento e Diretrizes de Saúde, a área técnica deverá:

I - solicitar a Declaração de Disponibilidade Orçamentária (DDO) para a Diretoria de Planejamento e Orçamento (DPO), que fará a avaliação da disponibilidade orçamentária;

II - enviar a minuta de Resolução de Financiamento e Diretrizes de Saúde para a área gestora com o objetivo de apoiar a articulação desta junto às URS, especialmente nas ações preparatórias;

III - enviar a minuta de Resolução de Financiamento e Diretrizes de Saúde, validada pelo Subsecretário(a) da respectiva área técnica, para avaliação dos indicadores pela Assessoria Estratégica, após aprovação pela área gestora;

IV - enviar a minuta de Resolução de Financiamento e Diretrizes de Saúde cuja redação extrapole os itens dispostos no §1º deste artigo, validada pelo Subsecretário(a) da respectiva área técnica e, quando for o caso, avaliada pela Assessoria Estratégica, para análise pela Assessoria Jurídica das questões jurídicas pontuais, devidamente delimitadas; e

V - solicitar pauta para apresentação da Resolução de Financiamento e Diretrizes de Saúde à Comissão Intergestores Bipartite (CIB-SUS/MG), nos termos do seu Regimento Interno.

§1º - Visando otimizar o fluxo de pactuações e publicações, a minuta padrão, contendo os artigos mínimos e obrigatórios para as Resoluções de financiamento, deverá observar o modelo previamente aprovado e disponibilizado às áreas técnicas.

§2º - A minuta de Resolução de Financiamento e Diretrizes de Saúde, quando couber, será submetida à CIB-SUS/MG, após aprovação dos Subsecretários(as) das respectivas áreas técnica e gestora, ficando dispensado quando se tratar de resolução de Financiamento e Diretrizes de Saúde decorrente de indicação de emenda parlamentar.

§3º - Para a elaboração, publicação e cadastro de Resolução de financiamento decorrente de indicação de emenda parlamentar, a instrumentalização e operacionalização dos atos será de responsabilidade da Diretoria de Convênios e



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Saúde

Resoluções (DCR), ficando a cargo da área técnica, responsável pelo referido objeto/ação orçamentária da indicação registrada no sistema Sigcon-Saída:

- I – emitir de parecer técnico assistencial da indicação parlamentar, quando demandada;
- II - definir indicador ou meta, nos termos do §1º do art.6º desta Resolução, a ser incluído em um anexo específico na resolução de financiamento e informar à Diretoria de Convênios e Resoluções, após validação pela Assessoria Estratégica;
- III – Appreciar e solicitar ajustes à minuta de resolução de Financiamento e Diretrizes de Saúde contendo o indicador ou meta validado, cujo texto-base será o da minuta-padrão previamente aprovada e disponibilizada às áreas técnicas, conforme dispõe o §1º deste artigo, inserindo aspectos técnicos relevantes do projeto.
- IV – assinar a Declaração de Disponibilidade Orçamentária (DDO) e ordenar as despesas de empenho, liquidação e pagamento, quando solicitado;
- V – monitorar o desempenho dos indicadores ou metas e execução orçamentária da política pública de saúde concernente ao objeto da Resolução de financiamento, conforme disposto no Art 3º desta Resolução.

Art. 8º – O processo de implementação da política será iniciado após a publicação da respectiva Resolução de Financiamento e Diretrizes de Saúde e efetivo repasse dos recursos financeiros

Art. 9º – A área técnica realizará o cadastro da Resolução de Financiamento e Diretrizes de Saúde em sistema de gerenciamento de resoluções estaduais de saúde.

Art. 10 – A área técnica disponibilizará o Termo de Adesão para assinatura dos beneficiários, conforme prazos previstos na Resolução de Financiamento e Diretrizes de Saúde, devendo acompanhar o processo de assinatura no sistema de gerenciamento de resoluções estaduais de saúde.

Parágrafo único - A área técnica deverá comunicar à área gestora a data prevista de disponibilização do Termo de Adesão, com antecedência mínima de 05 dias úteis, de forma a permitir o planejamento e a execução de ações articuladas com as Unidades Regionais de Saúde (URS), com vistas à mobilização e ao aumento da adesão dos beneficiários.

Art. 11 – Os procedimentos de descentralização, empenho, liquidação e pagamento das Resoluções de financiamento obedecerão ao regido na Resolução SES/MG nº 8.631, de 14 de março de 2023, ou a que vier a substituí-la.

Art. 13 – A área técnica deverá informar ao setor responsável pela formalização de contratos assistenciais, por meio de fluxo específico, sobre a contemplação de entidade sob gestão estadual em Resolução de Financiamento e Diretrizes da SES, solicitando



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Saúde

a inclusão dos recursos em contrato vigente ou a formalização de novo instrumento, nos termos do disposto no §2º do art. 4º do Decreto 49.080/2025.

§1º – As informações de que trata o *caput* deste artigo deverão abordar:

- I - objeto;
- II - prazo de vigência;
- III - valor;
- IV - cronograma de desembolso; e
- V - indicadores.

§2º – A área responsável pela formalização de contratos assistenciais poderá solicitar à área técnica informações complementares das políticas de que trata o *caput* deste artigo.

Art. 14 – O Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde, poderá atuar como interveniente nos contratos assistenciais cujo objeto são ações e serviços de saúde formalizados entre Município e prestadores de serviços hospitalares e ambulatoriais, estabelecendo compromissos para a qualificação da assistência e da gestão hospitalar no território.

CAPÍTULO IV – Do Monitoramento das Políticas Públicas de Saúde

Art. 15 - O processo de monitoramento será realizado em sistema de gerenciamento de resoluções estaduais de saúde, a partir da formalização de Termo de Adesão entre a SES/MG e o beneficiário.

Art. 16 – O monitoramento dos indicadores será realizado em períodos previamente definidos nas resoluções de financiamento, de acordo com as regras específicas de cada estratégia ou projeto de saúde, e em etapas distintas, com prazos estipulados, visando assegurar a organização e a eficiência da gestão.

§1º - As etapas de monitoramento de que trata o *caput* deste artigo, compreendem:

- I - coleta de dados dos indicadores declaratórios e oficiais;
- II - apuração e cálculo dos indicadores;
- III - ciência dos resultados apurados;
- IV - interposição de recursos; e
- V - análise e deliberação dos recursos apresentados.

§2º – Para a coleta de dados de indicadores declaratórios, os beneficiários deverão informar os dados e apresentar, obrigatoriamente, no sistema de gerenciamento de resoluções estaduais de saúde, a documentação comprobatória complementar, conforme os requisitos estabelecidos na ficha do indicador constante na Resolução de Financiamento e Diretrizes de Saúde..



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Saúde

§3º – Encerrado o prazo para coleta de dados, os indicadores declaratórios que não forem informados pelos beneficiários serão considerados com resultado igual a zero.

§4º – Na coleta de dados de indicadores oficiais, a área técnica será responsável pela compilação dos dados extraídos dos sistemas oficiais; apuração dos resultados, conforme as fórmulas de cálculo e faixas de desempenho, descritas na ficha do indicador constante na Resolução de Financiamento e Diretrizes de Saúde e; quando aplicáveis, registro no sistema de gerenciamento de resoluções estaduais de saúde.

§5º – A apuração dos indicadores será de responsabilidade da área técnica, em conformidade com os requisitos estabelecidos na Resolução de Financiamento e Diretrizes de Saúde, devendo os resultados apurados serem disponibilizados a todos os beneficiários para ciência no sistema de gerenciamento de resoluções estaduais de saúde.

§6º – O beneficiário deverá dar ciência aos resultados apurados sistema de gerenciamento de resoluções estaduais de saúde, dentro do prazo previamente estabelecido, podendo manifestar concordância ou interpor recurso contra os resultados informados.

§7º – Encerrado o prazo, o beneficiário que não der ciência aos resultados dentro do prazo estipulado perderá a prerrogativa de interpor recurso, fazendo jus ao recebimento da parcela calculada com base nos valores registrados no sistema de gerenciamento de resoluções estaduais de saúde.

§8º – A interposição de recursos deverá ser realizada pelos beneficiários por meio do sistema de gerenciamento de resoluções estaduais de saúde e direcionada à Comissão Macrorregional de Acompanhamento dentro do prazo estabelecido, devendo conter justificativa clara e objetiva quanto à contestação do resultado apurado, acompanhada da documentação comprobatória complementar que permita a adequada análise do caso.

§9º – Encerrado o prazo para a interposição de recurso, a ausência de justificativa, ou a não apresentação na forma prevista, implicará na perda do direito à análise pela Comissão Macrorregional de Acompanhamento, permanecendo válidos os resultados registrados no sistema de gerenciamento de resoluções estaduais de saúde, na etapa da ciência.

§10º – Os recursos interpostos tempestivamente e em conformidade com os critérios estabelecidos no sistema de gerenciamento de resoluções estaduais de saúde, serão analisados e deliberados pelas Comissões Macrorregionais de Acompanhamento, devendo os resultados finais serem registrados em ata.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Saúde

Art. 17 – Na ocorrência de fato superveniente, alheio à governabilidade dos beneficiários e da Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais – SES/MG, que comprometa a execução de qualquer das etapas do ciclo de monitoramento descrito no artigo 16, a área técnica poderá avaliar a prorrogação dos prazos inicialmente estabelecidos, com o objetivo de assegurar a continuidade e a regularidade do processo, observado o limite legal.

§1º – Consideram-se fatos supervenientes, desde que devidamente comprovados:

I – indisponibilidade do sistema de gerenciamento de resoluções estaduais de saúde ou falhas operacionais que comprometam sua funcionalidade; ou

II – ocorrência de catástrofes naturais, emergências de saúde pública ou outras situações excepcionais que inviabilizem a execução regular das etapas.

§2º – A identificação de fatos supervenientes por quaisquer áreas envolvidas no processo de monitoramento, seja no nível central, regional ou municipal, deverá ser comunicada formalmente à área técnica responsável, no menor tempo possível, para análise e adoção das providências cabíveis.

§3º – No caso de identificação de fatos supervenientes por parte dos beneficiários, estes deverão informar imediatamente a respectiva Unidade Regional de Saúde de sua abrangência, que se encarregará de repassar a informação à área técnica responsável, para fins de avaliação e encaminhamentos necessários.

Art. 18 – Compete à Comissão Macrorregional de Acompanhamento (CMA) analisar, deliberar e emitir parecer favorável ou desfavorável quanto aos recursos interpostos pelos beneficiários, nos seguintes casos:

I – perda de metas estabelecidas para os indicadores pactuados;

II – discordância quanto aos resultados apurados pela SES/MG no sistema de gerenciamento de resoluções estaduais de saúde; e

III – perda de prazo para a inserção dos dados relativos aos indicadores declaratórios.

Parágrafo único – Nos casos em que o beneficiário possua abrangência assistencial ou estrutura física envolvendo mais de uma macrorregião, a responsabilidade pela análise do recurso caberá à Comissão Macrorregional de Acompanhamento da macrorregião onde se localiza sua sede administrativa.

Art. 19 - Serão instituídas 3 (três) Comissões Macrorregionais de Acompanhamento em cada macrorregião de saúde, divididas por áreas de atuação:

I – Acesso a Serviços de Saúde;

II – Rede de Atenção à Saúde; e

III – Vigilância em Saúde.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Saúde

Parágrafo único - A área técnica responsável pela formulação da Estratégia ou Projeto de Saúde deve indicar obrigatoriamente na Resolução de Financiamento e Diretrizes de Saúde, de acordo com a correspondência temática, a Comissão Macrorregional de Acompanhamento encarregada de analisar os recursos relacionados aos resultados obtidos nos indicadores na etapa de monitoramento.

Art. 20 – As Comissões Macrorregionais de Acompanhamento serão disciplinadas por Regimento Interno, disposto em Resolução da SES/MG, que deverá conter, minimamente:

- I – composição de membros para cada uma das Comissões Macrorregionais de Acompanhamento das macrorregiões de saúde;
- II – fluxos, regras gerais de funcionamento e condutas a serem observadas na condução dos processos de análise e deliberação; e
- III – atribuições do coordenador, dos membros das Comissões e demais atores envolvidos no processo.

Art. 21 – Findado cada período de monitoramento, a área técnica providenciará, via sistema de gerenciamento de resoluções estaduais de saúde, o cálculo do valor a ser descontado da parcela seguinte ou devolvido para cada beneficiário, conforme a Resolução de financiamento.

§ 1º Caso não seja possível realizar o desconto na parcela seguinte, a área técnica solicitará o cálculo do valor atualizado à Diretoria de Prestação de Contas (DPC), e notificará o beneficiário para realizar a devolução do recurso atualizado.

§ 2º Em caso de descumprimento da devolução do recurso pelo beneficiário, conforme §1º deste artigo, a área técnica deverá enviar o processo para instrução do Processo Administrativo de Constituição de Crédito Estadual não Tributário - PACE, conforme Decreto Estadual 46.830/2015, pela Diretoria de Prestação de Contas.

Art. 22 – Compete à área gestora a coordenação das Comissões Macrorregionais de Acompanhamento e/ou de demais grupos temáticos vinculados ao monitoramento das políticas públicas de saúde, garantindo seu funcionamento e o encaminhamento das deliberações, em articulação com os demais níveis de gestão.

Art. 23 – A área gestora atuará em conjunto com as Unidades Regionais de Saúde na identificação e resolução de gargalos relacionados ao monitoramento das políticas públicas de saúde, bem como intermediar a comunicação entre essas unidades e a área técnica quanto às fragilidades observadas nos territórios, podendo induzir ou promover, quando necessário, ações que contribuam para sua superação, com vistas ao fortalecimento da gestão e apoio às áreas técnicas.

Art. 24 – A Superintendência de Planejamento e Finanças (SPF) realizará o acompanhamento das assinaturas dos ordenadores de despesas nos empenhos,



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Saúde

liquidações e ordens de pagamento, por meio do SIAFI-MG, ou sistema que vier a substituí-lo

Art. 25 – O monitoramento e avaliação de contratos assistenciais em que houver repasse de recurso estadual deverá observar os prazos e regras de monitoramento e avaliação constantes no Manual de Monitoramento e Avaliação de Contratos Assistenciais.

Art. 26 – O Município deverá encaminhar à Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES/MG) cópia dos contratos, convênios ou instrumentos congêneres firmados com prestadores de serviços no âmbito do SUS, para fins de registro e análise estratégica das informações, subsidiando o planejamento e a gestão do SUS em âmbito estadual.

§1º - O município deverá, ainda, disponibilizar nos Portais da Transparência de seu município a cópia dos instrumentos aos quais refere-se o *caput* deste artigo.

§2º O município deverá incentivar os seus prestadores de serviços a manterem-se atualizados no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES, considerando que essa fonte oficial poderá ser utilizada para subsidiar estratégias e projetos de saúde, bem como seus indicadores.

CAPÍTULO V – Da Prestação de Contas

Art. 27 – A Prestação de Contas dos Termos de Adesão ocorrerá nos termos da respectiva Resolução de Financiamento e Diretrizes de Saúde.

Art. 28 – A Prestação de Contas das estratégias de saúde será realizada anualmente, prioritariamente, por meio dos sistemas informatizados oficiais de saúde, considerando a produção de procedimentos, produtos, serviços assistenciais ou ações e serviços públicos de saúde nos moldes estabelecidos pela respectiva Resolução de Financiamento e Diretrizes de Saúde, conforme Seção II – Das Estratégias de Saúde, capítulo VIII, Da Prestação de Contas, do Decreto nº 49.080/2025.

§ 1º – Compete à área técnica apurar a produção de procedimentos, produtos, serviços assistenciais ou ações e serviços públicos de saúde para subsidiar a análise da política e a Prestação de Contas prevista no *caput* deste artigo, bem como a conformidade do uso do recurso ao bloco de financiamento em que está enquadrado.

§ 2º – Os Fundos de Saúde de Municípios, deverão, ainda, realizar a comprovação, de que trata o *caput* deste artigo, por meio do Relatório Anual de Gestão (RAG), que deve ser elaborado anualmente e submetido ao respectivo Conselho Municipal de Saúde - CMS.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Saúde

§ 3º – As pessoas jurídicas da Administração indireta deverão realizar a comprovação referida no caput deste artigo por meio da aprovação das demonstrações financeiras conforme estatuto da entidade no respectivo exercício, encaminhando-o para ciência do CMS do município onde é realizada a prestação de serviço.

§4º – Os beneficiários previstos nos incisos III, IV, VI e VII do art. 3º do Decreto nº 49.080/2025 deverão realizar a comprovação referida no caput deste artigo por meio da aprovação das demonstrações financeiras conforme estatuto da entidade no respectivo exercício, encaminhando-o para ciência do CMS do município onde é realizada a prestação do serviço ou para ciência do Conselho Estadual de Saúde no caso do COSEMS e CONASEMS.

§ 5º – Para os casos em que as estratégias de saúde se referirem a políticas cujo financiamento é, exclusivamente, por meio de incentivo, e não de produção, a Resolução vinculada a esta política deve apresentar indicadores mensuráveis os quais permitirão a aferição da produção de ações e serviços públicos de saúde vinculados a ela, viabilizando a avaliação do alcance das metas durante a etapa do monitoramento.

§ 6º - Os beneficiários que receberem recursos do FES para execução de estratégias de saúde possuem até o dia 30 de março ano seguinte ao da execução financeira para apresentação dos documentos tratados neste artigo.

Art. 29 – A Prestação de Contas dos projetos de saúde será iniciada após o fim da vigência do Termo de Adesão.

Art. 30 – Deverá ser apresentado processo de Prestação de Contas pelos beneficiários que receberam recursos por meio de projetos de saúde no prazo de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir do término da vigência da Resolução de Financiamento e Diretrizes de Saúde.

§1º – A área técnica responsável pelo projeto deverá abrir processo de Prestação de Contas, no sistema de gerenciamento informatizado disponibilizado pela SES/MG, ao final da vigência.

§2º – O beneficiário deverá preencher e assinar o formulário digital de Prestação de Contas em sistema informatizado disponibilizado pela SES/MG no prazo estabelecido no caput deste artigo.

§3º - Os Fundos Municipais de Saúde que possuem a gestão de seus prestadores de serviços, deverão prestar contas também dos beneficiários finais, no mesmo formulário mencionado no §2º deste artigo.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Saúde

Art. 31 – A Unidade Regional de Saúde verificará o cumprimento do prazo de Prestação de Contas estabelecido no §2º do artigo anterior, e notificará em até 5 (cinco) dias úteis, após o respectivo prazo, os beneficiários omissos para que regularizem a situação em até 30 (trinta) dias corridos após o recebimento da notificação.

§1º – Os beneficiários notificados deverão apresentar a prestação de contas no sistema GEICOM, ou sistema que vier a substituí-lo, caso contrário, ele ainda poderá:

I – apresentar justificativa para o descumprimento;

II – apresentar documentação complementar que comprove a regularização; ou

III – efetivar a devolução total do recurso recebido.

§2º – Após o prazo de manifestação dos beneficiários, cabe à Unidade Regional de Saúde verificar se as pendências foram sanadas e, caso o beneficiário tenha sanado a pendência ou tenha apresentado justificativa possível de ser acatada conforme os incisos I, II ou III, a Unidade Regional de Saúde deverá solicitar ao gestor do projeto que providencie a retirada da disponibilização da Prestação de Contas no sistema.

§3º – Caso as pendências não tenham sido sanadas pelo beneficiário, cabe à Unidade Regional de Saúde elaborar Relatório Consolidado de Omissão no Dever de Prestar Contas e encaminhá-lo para apreciação do ordenador de despesas.

§4º – Caso ocorra a reprovação por omissão do processo de Prestação de Contas pelo ordenador de despesa, será iniciado Processo Administrativo do Crédito Estadual (PACE) conforme regulamentado pelo Decreto Estadual nº 46.830/2015, ou o que vier a substituí-lo.

§5º – Nos casos em que o objeto pactuado pela Resolução de Financiamento e Diretrizes de Saúde envolver mais de uma Unidade Regional de Saúde, caberá à Diretoria de Prestação de Contas (DPC) realizar as atividades mencionadas no *caput* deste artigo e aquelas descritas nos parágrafos anteriores.

Art. 32 – Deverão ficar sob a posse do beneficiário, para os projetos de saúde e estratégias de saúde, no que couber, os seguintes documentos:

I - declaração de autenticidade dos documentos apresentados assinada pelo representante legal do beneficiário;

II - contrato e comprovante da sua publicidade e seus aditivos;

III - nota de empenho do beneficiado, se for o caso;

IV - comprovante de faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros documentos originais de comprovação de despesas, rotuladas com o número da Resolução de Financiamento e Diretrizes de Saúde e do Termo de Adesão, ou cópias acompanhadas de declaração de autenticidade dos documentos apresentados assinada pelo representante legal do beneficiário;



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Saúde

- V - comprovante de ordem bancária ou transferência eletrônica ou microfilmagem de cheque nominativo emitido para pagamento;
- VI - demonstrativo dos rendimentos de aplicação financeira;
- VII - documentos relativos aos processos de contratação de serviço e de aquisição e gestão de bens adquiridos, para a execução do objeto pactuado, se for o caso;
- VIII - comprovante de devolução, ao Tesouro Estadual, dos saldos em conta corrente e de aplicação financeira, somado a eventuais despesas vedadas glosadas, observados o artigo 12 do Decreto nº 49.080/2025 com o respectivo Documento de Arrecadação Estadual – DAE – ou, quando se tratar de recurso de fonte federal, comprovante de depósito na conta específica do FES do instrumento celebrado com a União;
- IX - comprovantes e guias de retenções e recolhimentos de impostos e encargos sociais incidentes, se for o caso;
- X - extratos da conta corrente específica do instrumento referentes ao período avaliado;
- XI - extratos da aplicação financeira do instrumento referentes ao período avaliado;
- XII - demonstrativo de execução de receita e despesa, evidenciando os recursos recebidos, os rendimentos de aplicação dos recursos e os saldos; XIII - contratos firmados para a execução do objeto pactuado, se for o caso;
- XIV - boletim de medição final assinado pelos representantes legais do beneficiário e da empresa ou concessionária da reforma ou obra e pelos responsáveis técnicos pela execução e pela fiscalização após a conclusão da reforma ou obra em modelo próprio;
- XV - termo de formalização da entrega da reforma ou obra, com laudo técnico pormenorizado;
- XVI - relação de pagamentos efetuados;
- XVII - relação de bens permanentes adquiridos ou produzidos;
- XVIII - cópia autenticada do Certificado de Registro para Licenciamento Veicular – CRLV – , caso o instrumento tenha por objeto a aquisição de veículo automotor;
- XIX - cópia autenticada da certidão de registro do imóvel adquirido, caso o instrumento versar sobre aquisição de bem imóvel; e
- XX - documentos que comprovem a realização de procedimento licitatório ou processo análogo de compra, especificando:
 - a) a modalidade utilizada;
 - b) o ato formal de dispensa ou inexigibilidade, quando for o caso, acompanhado da prova de sua publicidade em Diário Oficial ou jornal de grande circulação, com o respectivo embasamento legal;
 - c) os comprovantes da publicidade do edital ou do convite, quando for o caso,
 - d) termo de adesão e ata de registro de preços, quando for o caso; e
 - e) o respectivo resultado, contendo despacho adjudicatório e de homologação da licitação realizada ou ratificação da dispensa, acompanhado da prova de sua publicidade.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Saúde

Art. 33 – O procedimento de amostragem, previsto no art. 26 do Decreto 49.080/2025, refere-se à metodologia de prestação de contas das Resoluções de financiamento que garante a extensão dos resultados obtidos, por meio de análise parcial, ao universo de beneficiários de projetos de saúde.

§1º – O procedimento previsto no *caput* deste artigo será realizado pela Diretoria de Prestação de Contas (DPC), por meio de sorteio, em data e local a serem anunciados na primeira reunião ordinária da CIB-SUS/MG do ano ou pelo sistema.

§2º – A DPC utilizará como base para o sorteio o Relatório Operacional de Status de Assinatura de Prestação de Contas, ou documento que vier a substituí-lo, extraído do sistema de Prestação de Contas.

§3º – O sorteio será realizado mediante o agrupamento dos beneficiários por Unidade Regional de Saúde.

§4º – Para cada Unidade Regional de Saúde serão sorteados 25% dos beneficiários contemplados com o recurso do FES.

§5º – Para cada beneficiário sorteado pela SES/MG será sorteado um projeto de saúde, dentre os quais ele é signatário, para ser analisada a Prestação de Contas.

§6º – A DPC informará a Unidade Regional de Saúde os beneficiários sorteados em até 5 (cinco) dias úteis após o sorteio.

§7º – Após receber o comunicado, a Unidade Regional de Saúde tem até 2 (dois) úteis para notificar os beneficiários para apresentação da documentação listada no art. 30 desta Resolução.

§8º – O beneficiário notificado tem até 10 dias úteis para apresentar toda documentação requerida por meio eletrônico.

§9º – Caso o beneficiário não apresente a documentação no prazo estabelecido pelo §6º, a Unidade Regional de Saúde, deverá elaborar um relatório consolidado de omissão de dever de Prestação de Contas e apresentá-lo ao ordenador de despesas que, diante do relatório, decidirá pela reprovação das contas e, após a reprovação, iniciar o PACE.

§ 10º – Além do procedimento de que trata o *caput* deste artigo, a SES poderá analisar e fiscalizar outros processos de prestação de contas dos recursos repassados pelo FES.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Saúde

Art. 34 – Para análise da Prestação de Contas das estratégias ou projetos de saúde, nos casos de sorteio, para projetos de saúde, ou após constatação de indícios de irregularidades de que tratam os arts. 23 e 26 do Decreto 49.080/2025, a Unidade Regional de Saúde promoverá a conferência da documentação apresentada pelo beneficiário, verificando o cumprimento do objeto, da finalidade e o nexo de causalidade da receita e da despesa.

§ 1º – Finalizada a análise da Prestação de Contas, de que trata o *caput*, as áreas competentes emitirão pareceres que deverão atender, respectivamente, aos seguintes aspectos:

- I – parecer técnico: o cumprimento da execução física e o alcance dos objetivos da Resolução de Financiamento e Diretrizes de Saúde; e
- II – parecer financeiro: a correta e regular aplicação dos recursos da Resolução de Financiamento e Diretrizes de Saúde.

§ 2º – As áreas competentes deverão emitir os pareceres técnico e financeiro em até 150 (cento e cinquenta) dias corridos após o recebimento da apresentação da prestação de contas.

§ 3º Caso os pareceres não apresentem irregularidades ou invalidades, o setor de prestação de contas consolidará em relatório o processo de prestação de contas em até 30 (trinta) dias, contados do término do prazo do § 1º do art. 32 para decisão do ordenador de despesas.

Art. 35 – Na análise da Prestação de Contas dos projetos de saúde quando os pareceres apresentarem irregularidades ou invalidades, o setor de prestação de contas notificará o beneficiário, fixando o prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, para o saneamento das impropriedades e, se for o caso, para devolução dos recursos sob pena de instauração do Processo Administrativo de Constituição de Crédito Estadual (PACE) não Tributário decorrente de dano ao erário apurado em prestação de contas de transferências de recursos financeiros mediante parcerias PACE Parcerias

Parágrafo único - As áreas competentes deverão emendar os pareceres técnico e financeiro com base na resposta do conveniente em até 45 (quarenta e cinco) dias, após o fim do prazo previsto no *caput*.

Art. 36 – Após o prazo de notificação de que trata o art. 35, o setor de prestação de contas consolidará em relatório o processo de prestação de contas, em até 30 (trinta) dias, contados do término do prazo do § 1º do art. 35, para decisão do ordenador de despesas.

Parágrafo único – O relatório de que trata o *caput* deste artigo deverá consolidar os dados da Resolução de Financiamento e Diretrizes de Saúde e do Termo de Adesão e o histórico da prestação de contas, incluindo as irregularidades apuradas e, quando for



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Saúde

o caso, a memória de cálculo do valor a ser devolvido nos termos do art. 37 e as medidas administrativas adotadas.

Art. 37 – Na análise da prestação de contas final, verificados indícios de dano ao erário, o cálculo para a devolução dos recursos pelo beneficiário, bem como o cálculo do valor reprovado, deverá observar os seguintes critérios:

I – devolução integral dos recursos repassados pelo FES, na hipótese de omissão no dever de prestar contas, falta de comprovação total da execução, inclusive no caso de inexecução total do objeto, ou não comprovação da regularização da documentação do imóvel;

II – devolução do valor reprovado:

a) aquele necessário à conclusão do objeto do convênio ou irregularmente aplicado, conforme o caso, na hipótese de falta de comprovação parcial da execução ou de irregularidades, tais como glosa ou desvio na utilização dos recursos, falta de devolução de saldo dos recursos;

b) o rendimento não obtido calculado com base no montante não aplicado desde a data do recebimento do recurso até a data da conclusão do objeto ou do término da vigência, o que ocorrer primeiro, na hipótese de ausência de aplicação dos recursos;

Parágrafo único - Os débitos apurados serão atualizados e acrescidos de encargos legais com base nos índices convencionados ou adotados pela legislação específica, observado o que se segue, conforme IN 003/2013 do TCE-MG:

I – no caso de omissão no dever de prestar contas ou de as contas apresentadas não comprovarem a regular aplicação dos recursos, a atualização monetária e os juros moratórios incidirão a partir da data do crédito na conta bancária específica, quando conhecida, ou da data do repasse dos recursos, exceto nas ocorrências previstas no inciso II deste artigo;

II – quando houver impugnação de despesas específicas e os recursos tiverem sido aplicados no mercado financeiro ou quando caracterizada responsabilidade de terceiro, a atualização monetária e os juros moratórios incidirão a partir da data do pagamento;

III – nos demais casos, a atualização monetária e os juros moratórios incidirão a partir da data do evento, quando conhecida, ou da data de ciência do fato pela administração



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Saúde

Art. 38 – No âmbito da análise da prestação de contas, é permitido o parcelamento dos débitos oriundos dos cálculos estabelecidos no art. 36, conforme Decreto Estadual nº 46.830/2015 ou o que vier a substituí-lo.

Art. 39 – Caberá ao ordenador de despesas com fundamento no relatório consolidado a que se referem os arts. 34 e 35, no prazo de 30 (trinta) dias, aprovar a prestação de contas, se comprovada, de forma clara e objetiva, a execução do objeto, salvo no caso de dano ao erário.

§ 1º – A aprovação da prestação de contas receberá ressalvas quando evidenciada irregularidade ou invalidade de natureza formal da qual não resulte dano ao erário.

§ 2º – Verificada a ausência de comprovação do recolhimento de tributos, o FES deverá aprovar a prestação de contas com ressalvas e, ainda, comunicar a fazenda pública interessada.

§ 3º – O FES comunicará ao beneficiário, por meio de sistema, a aprovação da prestação de contas com ou sem ressalvas no prazo de 30 (trinta) dias corridos após a decisão.

§ 4º – Quando a prestação de contas final for aprovada, o ordenador de despesas autorizará o arquivamento da prestação de contas.

§ 5º – Quando a prestação de contas final for aprovada com ressalva, o ordenador de despesas autorizará o arquivamento e notificará o beneficiário para a adoção das medidas necessárias à correção das irregularidades ou invalidades identificadas, de modo a prevenir a reincidência.

§ 6º – Excepcionalmente, para os projetos de saúde em que não tenha havido qualquer execução física, nem utilização dos recursos, mas que tenha sido verificada a devolução pelo beneficiário dos recursos repassados pelo FES, observado o disposto no § 2º do art. 41, a prestação de contas poderá ser aprovada.

§ 7º – A prestação de contas não será aprovada quando houver falta de comprovação total ou parcial da aplicação de recursos no objeto pactuado no termo de adesão de projetos de saúde, ou dano ao erário apurado, inclusive por ocasião da omissão no dever de prestar contas, observado o disposto no art. 39.

§ 8º – Caso sejam identificadas irregularidades graves e insanáveis, o FES promoverá a representação ao TCEMG, nos termos do art. 70 da Lei Complementar nº 102, de 17 de janeiro de 2008.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Saúde

§ 9º – Para os efeitos desta resolução, consideram-se irregularidades graves e insanáveis os atos relevantes que apresentem potencialidade de prejuízos ao erário e que:

- I – ensejarem nulidade de procedimento licitatório ou de contrato;
- II – configurarem graves desvios dos princípios constitucionais a que está submetida a Administração Pública.

Art. 40 – Após a decisão final acerca das contas, caberá ao FES:

- I – Iniciar o Pace – Parcerias na hipótese de reprovação da prestação de contas;
- II – Registrar a inadimplência do conveniente no Siafi-MG, nas hipóteses de:
 - a) reprovação da prestação de contas em decorrência da omissão no dever de prestar contas;
 - b) reprovação da prestação de contas que não tenha como causa a omissão após o julgamento pelo Tribunal de Contas competente da Tomada de Contas Especial, ou procedimento análogo.

Art. 41 – Quando o atual representante legal do beneficiário não for o responsável pela causa da não aprovação da prestação de contas, inclusive no caso de omissão, o beneficiário poderá ser liberado para receber novas transferências, mediante suspensão da inadimplência por ato expresso do ordenador de despesa do FES, se comprovado cumulativamente que o atual representante legal do beneficiário:

- I – adotou as providências cabíveis para sanar as irregularidades ou omissão, inclusive eventual ajuizamento, pelo beneficiário, de medida judicial visando, conforme o caso, ao ressarcimento, à apresentação de documentos e à punição dos responsáveis;
- II – apresentou justificativa referente à impossibilidade de prestar contas dos recursos estaduais recebidos firmados pelos seus antecessores ou sanar as irregularidades verificadas;
- III – solicitou instauração a instauração do Pace – Parcerias, no caso de omissão.

§ 1º – Atendidos os requisitos dos incisos do *caput* e demonstrado que as irregularidades foram praticadas na gestão anterior, o FES deverá efetuar a suspensão do registro de inadimplência.

§ 2º – O beneficiário deverá comprovar, semestralmente, ao FES o prosseguimento da providência prevista no inciso I, sob pena do retorno à condição de inadimplência.

Art. 42 – O Processo Administrativo de Constituição de Crédito Estadual não Tributário, regulamentado pelo Decreto nº 46.830, de 14 de setembro de 2015, ou norma que vier a substituí-lo, obedecerá às normas e orientações expedidas pela AGE.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Saúde

CAPÍTULO VI - Das Disposições Finais

Art. 43 – Os termos de adesão firmados e vigentes na data de entrada em vigor deste decreto e que tenham como objeto a prestação de serviços de natureza continuada, permanecerão regidos pela legislação sob a qual foram celebrados até o término de suas respectivas vigências, ou até 1º de março de 2026, quando deverão ser revogados unilateralmente, o que ocorrer primeiro.

§1º - O saldo remanescente dos termos de que trata o *caput* deste artigo, deverá ser transferido para a conta bancária do respectivo bloco de financiamento até 1º de fevereiro de 2026, ou 60 (sessenta) dias após revogação tratada no *caput*.

§2º - O respectivo bloco para subsidiar as transferências bancárias será definido em normativo próprio.

Art. 44 – Os termos de compromisso e metas firmados e vigentes na data de entrada em vigor deste decreto e que tenham como objeto a realização de uma entrega por escopo, permanecerão regidos pela legislação sob a qual foram celebrados até o término de suas respectivas vigências.

Parágrafo único - O saldo remanescente dos termos de que trata o *caput* deste artigo, após o término de sua vigência, deverá ser devolvido ou, mediante autorização da SES, utilizado em atividades diretamente relacionadas à entrega por escopo prevista, durante sua vigência.

Art. 45 – Os termos de compromisso e metas firmados e vigentes na data de entrada em vigor desta resolução terão seus procedimentos de análise e deliberação de recursos, no âmbito do processo de monitoramento de indicadores, regidos pelas Comissões Macrorregionais de Acompanhamento, observando-se o ato jurídico perfeito, a partir da vigência desta resolução.

Art. 46 - Fica revogada a Resolução SES/MG nº 8.879, de 17 de julho de 2023.

Art. 47 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Belo Horizonte/MG, .

FÁBIO BACCHERETTI VITOR
SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Saúde

ANEXO ÚNICO DA RESOLUÇÃO SES Nº 10.382, DE 11 DE AGOSTO DE 2025.

TERMO DE ADESÃO

Pelo presente instrumento, **[NOME DO BENEFICIÁRIO]**, inscrito no **[CPF/CNPJ]**, doravante denominado **BENEFICIÁRIO**, formaliza sua adesão à/ao **[Estratégia ou Projeto de Saúde]** **[Nome da Estratégia ou Projeto de Saúde]**, conforme as disposições da **Resolução nº XXXX/2025** e demais normativas aplicáveis.

O **BENEFICIÁRIO** declara estar ciente e de acordo com as diretrizes, objetivos e condições estabelecidas, comprometendo-se a cumprir as exigências previstas para sua participação na referida resolução.

O recurso financeiro deste termo perfaz o valor global de R\$xxx, a ser repassado conforme regras da Resolução de referência.

Este termo entra em vigor na data de sua assinatura e permanecerá válido enquanto perdurarem as condições estabelecidas pela **Resolução nº XXXX/2025**, limitado a 60 meses, podendo ser rescindido por qualquer das partes mediante comunicação formal.

E, por estarem justos e acordados, assinam o presente termo.

[Local], [Data]

BENEFICIÁRIO

[Nome e Assinatura]